Educación en el dolor para personas ajenas al ámbito sanitario

Aspectos generales del manejo y control del dolor

tech

CONTENIDO

1. Objetivos
2. Introducción
3. Objetivos en la formación de paciente y entorno en materia de dolor
4. Bibliografía

Objetivos

- Mostrar al alumno la relevancia de la formación del paciente y su entorno para una adecuada participación en su proceso.
- Dar a conocer los factores más relevantes en la formación del personal no sanitario en materia de valoración y manejo de terapias analgésicas en domicilio.
- Hacer ver la relevancia del cuidado del entorno del paciente con dolor, y cuidar al cuidador.

Introducción

El dolor tanto agudo como crónico es un problema de salud que afecta a una alta tasa de la población. Según la *survey of chronic pain in Europe: prevalence, impact on daily life and treatment*[1], el 19% de los encuestados sufre dolor crónico moderado a severo.

Se estima que la incidencia de dolor en el ámbito hospitalario es de aproximadamente del 61,4%[2], estando los mayores niveles de dolor moderado-severo entre los pacientes postquirúrgicos, donde más del 50 % de los pacientes revelan haber padecido dolor moderado-severo según los estudios[3,4], aunque el dolor tiene alta incidencia también entre el grupo ingresados en unidades de medicina interna y psiquiatría[5].

Habitualmente, el manejo y control del dolor en el ámbito sanitario tanto en dolor agudo como en crónico están lideradas por el personal sanitario y aunque se valora la participación del paciente y familia, estos juegan un papel más pasivo.

En el ámbito domiciliario, sin embargo, el soporte por parte del personal sanitario no es tan cercano, lo que, en muchas ocasiones, supone un detrimento en la efectividad del control del dolor.

A menudo, se observan conductas en domicilio que suponen una polimedicación inadecuada, que conlleva a la presencia de efectos secundario o dependencia de ciertos fármacos y, en otras ocasiones, conductas derivadas del temor a efectos secundarios provoca en el paciente una disminución de las pautas a administrar y, por lo tanto, un infratratamiento del dolor.

Por otro lado, los sistemas parenterales de administración de fármacos tanto para el control del dolor crónico como del dolor agudo postoperatorio han mejorado sustancialmente el control del dolor, permitiendo la ambulatorización de muchos procesos con igual estándar de calidad y con una mejor relación, coste, efectividad y gran satisfacción por parte del paciente y sus cuidadores.

No obstante, estos sistemas requieren de formación por parte del paciente y sus cuidadores para evitar errores en la administración o complicaciones. En la actualidad, se trata de promover el rol activo del paciente y su entorno en el control del dolor; en este sentido, se establecen estrategias de educación del dolor para pacientes y su entorno.

A continuación, se abordan los aspectos relacionados con el control del dolor por parte del paciente y de su entorno en el contexto del dolor agudo, sobre todo el dolor agudo postoperatorio, y el dolor crónico benigno, y oncológico.

Objetivos en la formación de pacientes y entornos en materia de dolor

El autocuidado es definido por la organización mundial de la salud (OMS) como la capacidad de las personas, familias y comunidades para promover la salud, prevenir enfermedades, mantener la salud y hacer frente a enfermedades y discapacidades con o sin el apoyo de un prestador de atención de salud.

El autocuidado es considerado un recurso sanitario fundamental del sistema de atención de salud. La OMS considera que es necesario potenciar las intervenciones en autocuidado como medio para potenciar la autonomía, la autoeficacia y el compromiso con la salud.

En el ámbito del control del dolor, la participación del paciente y el cuidador supone la posibilidad de mejora, sustancialmente, de la calidad de vida del paciente que está sufriendo el dolor, la mejoría clínica y la recuperación de sus funciones.

La educación en medidas preventivas y terapéuticas del paciente, y su entorno, permitirán que el control del dolor a domicilio sea efectivo y seguro *(Tabla 1)*.

La educación en materia del dolor no está enfocada sólo en el bienestar del paciente que sufre dolor, el concepto de educación en dolor incluye el cuidado del cuidador. En el ámbito del dolor se considera al cuidador o cuidadores como la o las personas que asumen la responsabilidad del cuidado de la persona con dolor, así como la participación en la toma de decisiones en lo que respecta a la salud del paciente con dolor[6].

Objetivos de la formación en dolor del personal no sanitario
Disminuir los niveles de ansiedad con respecto al dolor.
Disminuir la percepción del dolor.
Minimizar el número de traslados al hospital o servicios de urgencias.
Monitorizar la evolución del dolor y la respuesta a tratamiento en domicilio.
Detectar la presencia de efectos secundarios al tratamiento.
Prevenir efectos físicos y mentales sobre familiares y cuidadores.

Tabla 1. Objetivos de la formación en dolor de personal no sanitario.

Muy habitualmente en el cuidado del paciente con patología que cursa con dolor, el tratamiento de este síntoma se convierte en prioritario; el cuidador se enfrenta con ansiedad a la posibilidad de la presencia del dolor y al manejo del tratamiento de este.

Es necesario, desde medidas educativas, aportar estrategias y herramientas efectivas para el control del dolor. Asimismo, es necesario establecer medidas preventivas para evitar la aparición de sintomatología en el propio cuidador como consecuencia de su actividad para con el paciente; la sintomatología puede ser dolor osteomuscular o síntomas ansioso-depresivos, muy frecuentemente asociados a este colectivo[7-9].

- **Estrategias de comunicación e información:**

  En el modelo de participación del paciente y sus cuidadores, en el manejo y control del dolor, es imprescindible que se establezca una relación de confianza entre el equipo clínico y el paciente basada en la comunicación.

  La comunicación entre el médico-paciente no siempre es fácil y se complica especialmente cuando se establece en situaciones estresantes, asociadas a un gran componente afectivo y emocional como el dolor o las situaciones terminales.

  Una adecuada comunicación entre el médico y el paciente debe ser clara, honesta y acorde a las capacidades de entendimiento de pacientes y su entorno; esto aporta las ventajas de disminuir el impacto emocional de la patología, que puede tener repercusión muy negativa en la evolución del dolor y su patología de origen[10], facilita el papel activo del paciente sobre el control del problema y el mantenimiento de la autonomía del paciente ante la situación de dolor, aumenta la fidelización al tratamiento y refuerza el papel de apoyo del cuidador, facilitando que el paciente no se encuentre aislado ante su problema clínico *(Figura 1)*.

  No obstante, múltiples estudios han evidenciado las dificultades de comunicación y la falta de aprendizaje de técnicas de comunicación entre el personal sanitario[11], algo que muchos autores consideran esencial[12].

  Las intervenciones clínicas, en las que se tratan de forma específica las estrategias de comunicación entre el médico y el paciente, han demostrado mejorar la respuesta del paciente y su entorno ante una situación clínica difícil como puede ser el dolor crónico[13].

  En la actualidad, la formación de clínicos en estrategias de comunicación se considera del todo insuficiente en el ámbito médico intrahospitalario y ambulatorio[14,15], lo que genera que se incurra en errores que potencian las barreras en la comunicación médico paciente *(Figura 2)*.

  Todo ello ha generado la necesidad de introducir formación en estrategias de comunicación entre los colectivos médicos[16].

El nuevo paradigma, que postula la necesidad de que el paciente tome parte activa en los procesos clínicos, supone una gran ventaja en el manejo del dolor por parte del paciente, y se adapta al nuevo enfoque psicosocial del dolor.

El acceso a información concerniente a su patología es un derecho del paciente, por ende, el médico debe estar preparado para aportar esa información de la forma más adecuada posible. En la actualidad, la *agency for healthcare research and quality* establece entre sus recomendaciones una adecuada información al paciente, además, se debe promocionar la participación de este y su entorno en las decisiones que le conciernen.

Con ello, se contribuirá a mejorar la respuesta al tratamiento, se optimizarán recursos sanitarios, y se promocionará la cultura del autocuidado entre la población[17,18] *(Tabla 2)*.

Se dan una serie de estrategias que se pueden emplear para la mejora de la relación médico-paciente; la formación de los profesionales debe ir encaminada a la adquisición de habilidades que les permitan desarrollar estas estrategias en el ámbito de la práctica clínica:

- **Educación de personal no sanitario en estrategias de evaluación del dolor:**

  La sociedad americana del dolor establece que un buen control del dolor precisa una evaluación continua del dolor y de su respuesta al tratamiento. Esta premisa requiere una atención continua hacia el paciente, tanto en el medio hospitalario como en el ámbito domiciliario.

Emociones negativas	Estrategias de comunicación	Respuesta
• Miedo • Incertidumbre • Indefensión • Aislamiento	• Informacion clara y honesta • Ajustada	• Autocontrol • Respeto mutuo • Confianza • Afrontamiento

Figura 1. Papel de las estrategias de comunicaciones entre médico y paciente.

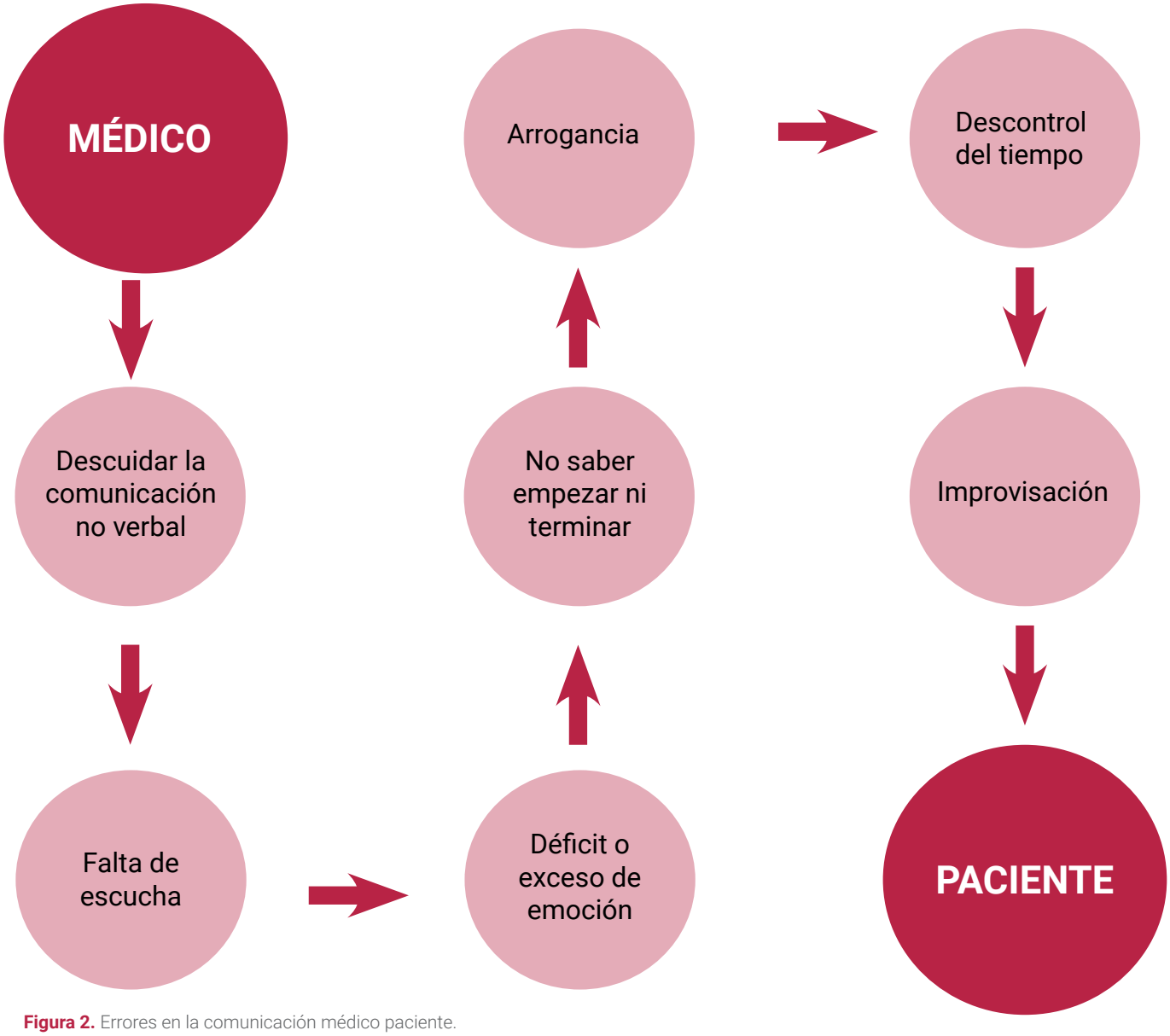

Figura 2. Errores en la comunicación médico paciente.

Estrategias para la mejora de la relación médico paciente
Presentación por parte del clínico del uso de normas de cortesía; informar al paciente de la actitud a tomar en su caso.
Adaptar el tiempo de la visita a las necesidades de cada paciente/patología: priorización del tiempo.
Preparación de protocolos para detectar aspectos que distorsionan la relación médico-paciente.
Favorecer el contacto visual, mostrar actitud de acercamiento al paciente (acompañar).
Participar como clínico en cuestiones relacionadas con la gestión de recursos.
Potenciar un entorno físico adecuado que favorezca la confortabilidad y la comunicación médico-paciente.
Promocionar la preparación de la visita médica por parte del paciente: preparar sus dudas y preguntas.
Formación específica en comunicación para el personal sanitario.
Fomentar las decisiones compartidas.
Potenciar las TICs* para mejorar la comunicación, siempre como un complemento de la atención personalizada.

*TICs: tecnologías de la información y la comunicación.

Tabla 2. Estrategias para la mejora de la relación médico-paciente.

El dolor es un síntoma que sufre una gran parte de la población y la demanda asistencial multidisciplinar requiere un seguimiento estrecho y supone un consumo de recursos que en muchas ocasiones resultará inviable. Por eso, es tan importante el papel del propio paciente y de su entorno más inmediato en la valoración del dolor.

A menudo, en las consultas del dolor se aprecia que el paciente y su entorno parecen tener una concepción clara de su situación clínica, no obstante, es frecuente que la interpretación de la situación sea muy diferente cuando se comparan las repuestas del propio paciente y sus familiares.

La percepción y la integración cognoscitiva suelen tener connotaciones personales que influyen mucho en la información que trasladan al personal sanitario.

De esta manera, en muchas ocasiones, la información transmitida a los profesionales de la salud no es tan objetiva como se desearía, y no resulta útil a la hora de establecer y evaluar el plan terapéutico del paciente.

En este sentido, es necesario establecer un plan de formación del paciente y su entorno para una evaluación del dolor lo más objetiva y útil posible.

En el control del dolor agudo, a menudo, el paciente y sus cuidadores deben evaluar el dolor para determinar el tratamiento que se precisa, es el caso de las prescripciones 'a demanda' o el manejo del dolor agudo postoperatorio en el ámbito de la cirugía mayor ambulatoria.

En el ámbito de la cirugía mayor ambulatoria, se tiene una amplia experiencia en el manejo del dolor por parte del paciente y sus cuidadores. En estos casos, es preciso transmitir a los cuidadores, que regularmente no están relacionados con el ámbito sanitario, los métodos a su disposición para la evaluación del dolor.

Es habitual y aconsejable tener una entrevista con el paciente en el periodo preoperatorio, en la que se explican las expectativas con respecto al dolor esperado en esa cirugía, el plan terapéutico previsto y el papel que el paciente y el cuidador tendrán en este plan. Además de establecer una vía de conexión directa con los profesionales sanitarios para la resolución de dudas.

Las recomendaciones en este sentido avalan la necesidad de una formación adecuada de profesionales, de pacientes y cuidadores en el control del dolor a domicilio[19].

En el ámbito del dolor crónico, es preciso establecer las mismas pautas en consultas encaminadas a enseñar al paciente a evaluar su dolor, de este modo, se podrán evaluar el grado de respuesta al tratamiento, los niveles de dolor que sufre el paciente, además, se podrá discriminar el dolor irruptivo, sus posibles pautas terapéuticas, y con ello, se mejorará el resultado.

Promocionar la autonomía de los pacientes, además, resulta en una mejora de la percepción del dolor por parte del paciente e influye positivamente en la disminución de efectos secundarios y dependencia a fármacos, al tiempo de ser una medida costo efectiva.

Los métodos de valoración del dolor en domicilio deben ser sencillos, fidedignos y deben permitir la toma de decisiones a los cuidadores no profesionales.

En la práctica clínica resulta muy útil el empleo de escalas descriptivas simples por parte del personal no sanitario. Algunas escalas muy útiles para la evaluación del dolor en el ámbito familiar, dada su accesibilidad y fácil comprensión, son: la escala EVA, la escala de la expresión facial, la escala de valoración del alivio y la escala de descripción del dolor[20]; estas escalas ofrecen una valoración altamente objetiva del dolor del paciente y son muy empleadas, a pesar de una valoración unidimensional del dolor.

Las escalas multidimensionales como el test de Mc Gill[21], incluyen una valoración temporo-espacial, afectivo-motivacional y evaluativa, e incluye escalas de valoración objetiva del dolor o el Wisconsin Brief Pain, este se postula como un buen método para la evaluación de la respuesta al tratamiento[22].

Además, permiten una evaluación del dolor más completa y su uso en el ámbito del dolor es muy habitual, no obstante, precisa de ser interpretado por profesionales médicos, por lo que su valor en el contexto del cuidador no profesional sanitario es mucho más limitado.

- **Formación de personal no sanitario en medidas terapéuticas para el control del dolor:**

Uno de los principales objetivos de la correcta evaluación del dolor, por parte de los cuidadores en el domicilio, es que obtengan la capacitación para tomar decisiones en cuanto al manejo terapéutico en domicilio. Con ello, se pretende mejorar el bienestar del paciente y su entorno, y minimizar las necesidades de asistencia sanitaria profesional.

Lo ideal es que el control del dolor se haga en el ámbito extrahospitalario. No obstante, ello supone la formación de los pacientes en el manejo de fármacos y vías de administración, así como de técnicas alternativas.

En cuanto al manejo farmacológico, la OMS establece la premisa de que preferiblemente se debe emplear la vía oral para el control del dolor. En este caso, la administración hospitalaria de fármacos no plantea ventajas con respecto a la administración domiciliaria.

Es necesario que la familia conozca los fármacos que se van a prescribir, sus contraindicaciones y efectos secundarios, y formar a los cuidadores en la detección de complicaciones asociadas al empleo de estos medicamentos.

Además, el entorno del paciente debe disponer de un enlace directo con servicios médicos en el caso de que se detecten dichas complicaciones.

Los cuidadores y pacientes deben tener una información realista de los resultados del tratamiento que se le ha prescrito, y acceso a instrucciones claras sobre la forma de administración de los fármacos.

Cuando la vía de administración oral no es posible o es insuficiente se puede recurrir a otras vías de administración y terapias invasivas a domicilio.

En el dolor agudo o inestable, o en casos de dolor agudo postoperatorio, la analgesia controlada por el paciente (PCA) es una buena opción. Los pacientes y familiares deben ser instruidos en el funcionamiento de estos dispositivos de uso tanto intra como extrahospitalario.

Los dispositivos de PCA permiten la administración de múltiples tipos de fármacos; el nivel de autonomía del paciente a la hora de dosificar el fármaco dependerá del tipo del fármaco, el grado de dolor y tipo de dolor esperado, y del grado de comprensión por parte de pacientes y familiares sobre el uso de estos dispositivos.

Este método es habitualmente empleado en el control del dolor del parto, así como el control del dolor postoperatorio en cirugía mayor ambulatoria.

En el caso de control del dolor crónico, son más habituales los sistemas terapéuticos transdérmicos (TTS), más adecuados para el dolor estable y mantenido en el tiempo. Permiten, al igual que los anteriores, un adecuado control del dolor basado en la autonomía del paciente para determinar sus necesidades.

Los métodos transdérmicos son casi siempre bien aceptados por los pacientes y no presentan el grado de disconfort de métodos invasivos como el intravenoso o el epidural. Además, se pueden asociar a terapias controladas por el paciente en el dolor agudo postoperatorio.

Comúnmente, los pacientes deben conocer los cuidados en el manejo de dispositivos parenterales para evitar efectos derivados de la sobre o infradosificación, infecciones o extravasaciones de medicación.

El empleo de técnicas locorregionales para control el dolor agudo, irruptivo y crónico, como pueden ser la administración de fármacos vía epidural o los bloqueos nerviosos, son altamente efectivos y a menudo se emplean para disminuir la administración de fármacos por vía oral o intravenosa.

No obstante, en el entorno familiar la aceptación es menor. Los pacientes y cuidadores pueden sentirse inseguros ante estas técnicas analgésicas no habituales y sentir cierto rechazo ante ellas.

En los casos en los que esté indicado, es precisa una información clara y detallada para el manejo y cuidado en estos casos. A menudo, se requiere un aprendizaje, por parte del paciente y la familia, que comienza en el ámbito hospitalario.

Previamente a la realización de la técnica, los pacientes deben ser supervisados y el equipo sanitario debe hacer un seguimiento del aprendizaje, también, un buen uso de estos métodos invasivos para garantizar el éxito de la técnica, así como la seguridad del paciente.

Igualmente, es relevante que el cuidador sea consciente de la importancia de las terapias físicas y psicológicas enfocadas al mejor control del dolor, por un lado, a la recuperación de funciones del paciente y al bienestar mental del mismo.

Estas terapias deben ser realizadas a diario y de forma repetitiva para obtener los máximos beneficios; muy frecuentemente, el cuidador será la persona que realice los ejercicios pautados por el fisioterapeuta y el rehabilitador en casa.

Es esencial que el cuidador conozca las técnicas y las realice de forma adecuada para evitar molestias innecesarias en el paciente, así como lesiones a sí mismo, durante la movilización.

Por otra parte, es fundamental que el cuidador sea capaz de generar en el domicilio un ambiente adecuado para que el paciente pueda realizar las terapias psicológicas autoadministradas, como lo son los ejercicios de relajación.

- **Soporte y asistencia psicológica al entorno del paciente con dolor:**

El entorno del paciente, y en especial el cuidador no sanitario del mismo, actúa de puente entre los sistemas sanitarios y el paciente, y puede llegar a jugar un rol realmente imprescindible en el cuidado del paciente.

El aprendizaje del dolor crónico, la formación en técnicas, el manejo de analgésicos y el origen de la patología son factores que contribuyen a la mayor implicación del entorno por el cuidado del paciente, así como mayor comprensión del estado del paciente.

No obstante, el cuidador se encuentra expuesto a situaciones de estrés asociadas al cuidado de la persona dependiente, para los que, regularmente, no ha sido preparado.

Esta exposición crónica puede desencadenar en lo que hoy en día se llama *Síndrome del cuidador* que cursa con sintomatología física como lumbalgia, dolor generalizado, cefaleas, cansancio y alteraciones psicológicas como ansiedad o depresión.

En la actualidad, se considera esencial el cuidado del cuidador con la implantación de medidas preventivas, de detección precoz y terapias para el control de la repercusión negativa del dolor en el entorno[23].

Pese a que son necesarias en el manejo del dolor agudo, el abordaje del estado psicológico del cuidador se hará más necesario en el caso de dolor crónico tanto oncológico como no oncológico. La atención al cuidador tendrá como objetivo obtener el bienestar del cuidador principal[24] *(Tabla 3)*.

El primer paso para el abordaje psicológico del cuidador es informar la evaluación de su estado, para ello existen una serie de escalas que tratan de objetivar el impacto que las tareas de cuidador tienen sobre su bienestar.

Se cuenta con la escala de carga de Zarit, la cual consta de 21 ítems y mide tres dimensiones subyacentes a la carga que son: impacto de cuidado, carga interpersonal y expectativas de autoeficacia.

Esta escala mide el grado en que los cuidadores perciben que sus responsabilidades tienen efectos adversos sobre su salud, vida personal y social, finanzas y bienestar emocional[25].

El Inventario de autovaloración de depresión estado (IDERE) y el inventario de ansiedad estado (IDARE) que evalúa los rasgos de personalidad depresiva y ansiedad, así como el estado de ansiedad o depresión reactiva.

Para la evaluación del cuidador y determinación de las medidas de intervención necesarias será preciso, asimismo, estudiar las características del paciente, así como el entorno social que envuelve al cuidador.

Una vez establecidos los riesgos psicológicos del cuidador, se deben poner en marcha intervenciones encaminadas a la prevención y el control de las disfunciones que la situación puede generar en el paciente o de las posibles descompensaciones de patología previa que el cuidador puede padecer.

El enfoque intervencionista deberá venir desde sesiones informativas, formativas y de apoyo emocional que oriente al cuidador a una actitud de cuidar y de cuidarse, promocionando el descanso, el ocio, el tiempo para sí mismo como parte del manejo global de la situación del paciente dependiente[26-28].

Son múltiples las intervenciones que se describen en la bibliografía, la mayoría de ellas son de tipo psicoeducacional. De esta manera, se aplican frecuentemente terapias cognitivas conductuales de la misma naturaleza que las aplicadas al propio paciente, con el fin de evitar conductas cognitivas distorsionadas o aberrantes que desemboquen en una claudicación del cuidador y su entorno.

La mayoría de los programas de intervención se enfoca en aportar a los cuidadores herramientas que les permitan gestionar el estrés y les ayuden a buscar soluciones basadas fundamentalmente en terapias de grupo o en acciones individuales[29-32].

- **Abordaje multidisciplinar para la educación en dolor en personal no sanitario:**

Dorothea Orem, en su Teoría del déficit del autocuidado, concibe al ser humano como un organismo biológico, racional y pensante. Los seres humanos tienen la capacidad de reflexionar sobre sí mismos y su entorno, capacidad para simbolizar lo que experimentan y usar creaciones simbólicas (ideas, palabras) para pensar, comunicarse y guiar los esfuerzos para hacer cosas que son beneficiosas para sí mismos y para otros.

Bienestar en el cuidador informal
Buen estado de salud percibido y objetivo.
Control sobre su realidad cotidiana.
Capacidad para tomar decisiones y optimizar los apoyos disponibles.
Minimizar el riesgo de dependencia futura provocada por los cuidados ejercidos.
Integración comunitaria y social.

Tabla 3. Factores definitorios del bienestar del cuidador.

Orem define los cuidados de enfermería como "el ayudar al individuo a llevar a cabo y mantener acciones de autocuidado para conservar la salud y la vida, recuperarse de la enfermedad y afrontar las consecuencias de ésta".

El entorno es entendido en este modelo como todos aquellos factores, físicos, químicos, biológicos y sociales, ya sean familiares o comunitarios, que pueden influir e interactuar en la persona. Finalmente, el concepto de salud es definido como un estado que, para la persona, significa cosas diferentes en sus distintos componentes y varía a medida que cambian las características humanas y biológicas de la persona[33].

La educación en el autocuidado debe comprender todos los ámbitos de la dimensión humana y deber ser realizada por un equipo multidisciplinar especializado en el paciente con dolor y su entorno. El dolor como síntoma y como patología propiamente dicha, afecta aspectos emocionales, físicos y sociales del paciente y de su cuidador principal.

El propio paciente y su entorno deben recibir formación adecuada respecto a todos los ámbitos que envuelven al dolor. Basándose en que el principio de autonomía del paciente supone una mejora en la calidad de vida de este, pero para ello, requiere una formación adecuada que le permita tomar decisiones en su proceso.

Los aspectos básicos del enfoque multidisciplinar de la formación del paciente y su entorno como personal no sanitario se muestran en la *figura 3*.

El aprendizaje, por parte del paciente y el entorno, supone que el paciente juegue un papel protagonista, pero siempre será acompañado por el equipo de médicos, enfermeros, psicólogos, rehabilitadores y fisioterapeutas que suelen componer los equipos multidisciplinares del control del dolor. El objetivo final de este modelo es que el paciente y su familia formen parte activa en el manejo de su proceso clínico.

Bibliografía

1. Breivik H, Collett B, Ventafridda V, Cohen R, Gallacher D. Survey of chronic pain in Europe: prevalence, impact on daily life, and treatment. Eur J Pain. 2006 May;10(4):287-333.
2. Padrol A, Pérez-Esquiva M, Olona M, Francesch A, Tomas I, Rull M. Estudio de la prevalencia del dolor en pacientes hospitalizados. Rev Soc Esp Dolor 2001; 8: 555 – 561.
3. Muñoz-Blanco F, Salmerón J, Santiago J, Marcote C. Complicaciones del dolor postoperatorio. Rev. Soc. Esp. Dolor 2001; 8: 194 – 211.
4. Gallego JI, Rodríguez de la Torre MR, Vázquez-Guerrero JC, Gil M. Estimación de la prevalencia e intensidad del dolor postoperatorio y su relación con la satisfacción de los pacientes. Rev Soc Esp Dolor 2004; 11:197 – 202.
5. Arbonés E, Montes A, Riu M, Farriols C, Mínguez S, Comisión para la Evaluación y Tratamiento del Dolor del Institut Municipal d'Assistència Sanitària (IMAS). El dolor en los pacientes hospitalizados: estudio transversal de la información, la evaluación y el tratamiento. Rev Soc Esp Dolor. 2009;16(6): 314 – 322.
6. Crespo LM, López MJ.2007. El estrés en cuidadores de mayores dependientes, Cuidarse para Cuidar. Ediciones. 1 edición. Editorial Pirámide., Madrid España. p. 278.
7. Douglas SL, Baly BJ, Kelley CG, O´Toole E, Montenegro H.Impact of a disease management program upon caregivers ofchronically critically ill patients. Chest 2005; 128:3925-3936.
8. López O, Lorenzo A, Santiago P. Morbilidad en cuidadores de pacientes confinados en su domicilio. Aten Primaria 1999; 24:404-410.
9. Roca M, Úbeda I, Fuentelsaz C, López R, Pont A, García L et al. Impacto del hecho de cuidar en la salud de los cuidadores familiares. Aten Primaria 2000; 26:53-67.
10. Monsalve V, Cerdá-Olmedo G, Mínguez A y De Andrés JA. Ansiedad y depresión en pacientes domiciliarios vs. ambulatorios con dolor crónico. Rev Soc Esp Dolor 2000; 7: 6-11.
11. Lerman C, Daly M, Sands C et al. Prevalence, predictive factors and screening for psychological distress in patients with newly diagnosed head and neck cancer. Cancer 2000;88: 2817-2823.

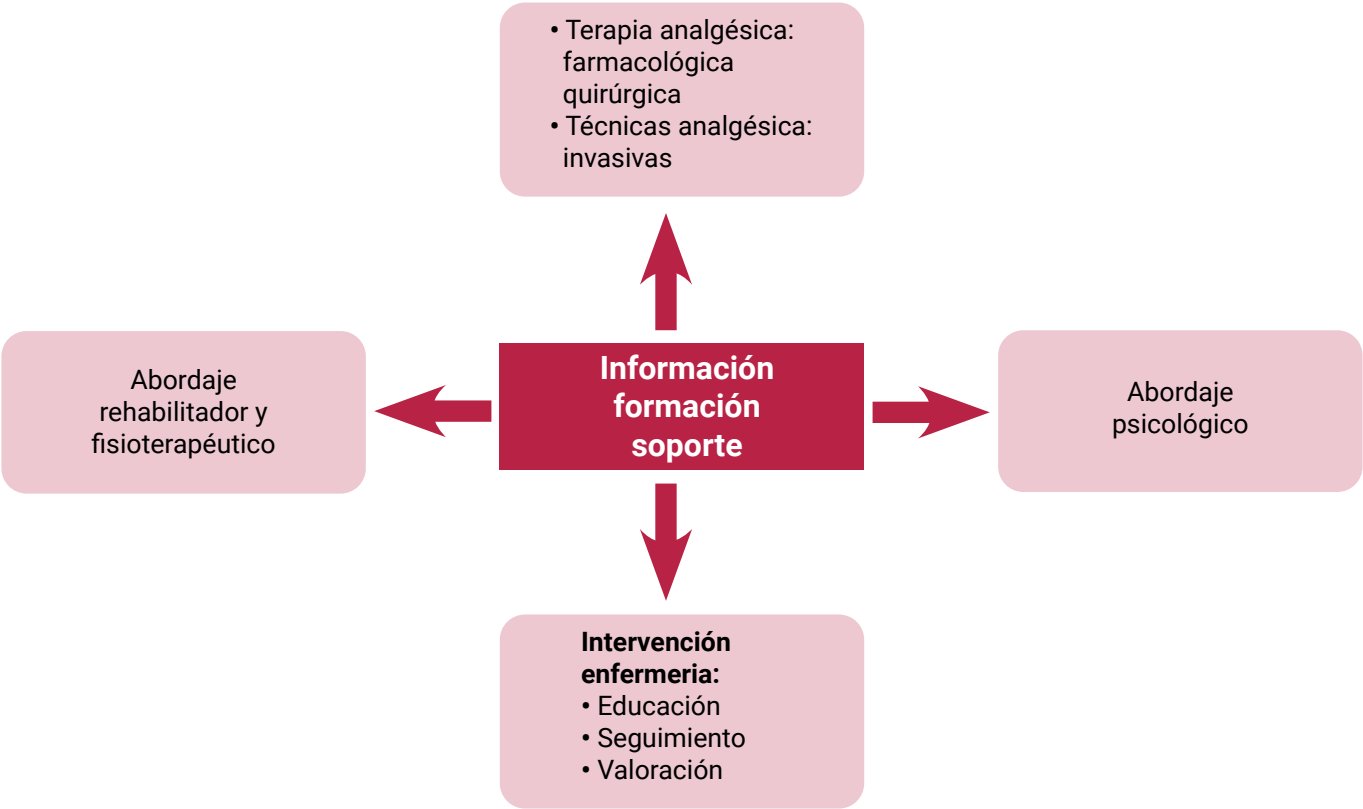

Figura 3. Aspectos básicos del enfoque multidisciplinar.

12. González Barboteo J, Bruera E. Avances en la comunicación médico-paciente en cuidados paliativos (I). Tomas de decisiones. Ayudas prácticas en la comunicación. Med Pal 2003;10 (4):226-234.
13. Jaya K, Anderson L, Inui T, Frankel R Communication Interventions Make A Difference in Conversations Between Physicians and Patients: A Systematic Review of the Evidence.Medical Care: 2007; 45(4):340-349.
14. Markakis KM, Beckman HB, Suchman AL, Frankel RM: The path to professionalism: cultivating humanistic values and attitudes in residency training. Acad Med 2000, 75(2):141-150.
15. Sise MJ, Sise CB, Sack DI, Goerhing M: Surgeons' attitudes about communicating with patients and their families. Curr Surg 2006, 63(3):213-218.
16. Rodríguez H, Anastario M, Frankel R, et al. Can teaching agenda-setting skills to physicians improve clinical interaction quality? A controlled intervention . BMC Medical Education 2008, 8:3.
17. Agency for Healthcare Research and Quality. Medical Errors & Patient Safety Disponible en: http://www.ahrq.gov/qual/errorsix.htm.
18. Declaración de Barcelona: Decálogo de los pacientes. Barcelona, 20–21 de mayo de 2003 [Disponible en: http://www.fbjoseplaporte.org/dbcn/.
19. Management of Postoperative Pain: A Clinical Practice Guideline From the American Pain Society, the American Society of Regional Anesthesia and Pain Medicine, and the American Society of Anesthesiologists' Committee on Regional Anesthesia, Executive Committee, and Administrative Council.Chou R, Gordon DB, de Leon-Casasola OA, et al. J Pain. 2016 Feb;17(2):131-57.
20. Turk DC. Assess the person, not just the pain.Pain Clinical Updates 1993; 1(3):1-4.
21. Melzack R.The McGill Pain Questionnaire: Major properties and scoring methods Pain 1975;1(3): 277-299.
22. Charles S. Cleeland, The Brief Pain Inventory User Guide, año 2009 URL: https://www.mdanderson.org/documents/Departments-and-Divisions/Symptom-Research/BPI_UserGuide.pdf.
23. Cruz Roja Española. Ser Cuidador. Blog Ser cuidador. Emociones letales en los cuidados. 2009 Disponible en: http://www.cruzroja.es/blojsom/blog/blogsercuidador/Ser+Cuidador/2011/07/05/Emociones-letales-en-los-cuidados1.html.
24. Sercuidadora.org (Internet). La dimensión emocional de los cuidados. Guía básica para la gestión de los pensamientos erróneos. Madrid; Cruz Roja Española. Disponible en: http://www.sercuidador.org/pensamientos/Dimension-emocional-ESPACIOS.pdf.

25. Montorio I, Fernández MI, López A, Sánchez M. La entrevista de carga del cuidador. Utilidad y validez del concepto de carga. Anales Psicol. 1998;14(2):229-48. Disponible en: https://www.um.es/analesps/v14/v14_2/09-14-2.pdf.
26. Zabalegui A, Navarro M, Cabrera E, Gallart A, Bardallo MD, Rodríguez E et al. Eficacia de las intervenciones dirigidas a cuidadores principales de personas dependientes mayores de 65 años: una revisión sistemática. Rev Esp Geriatr Gerontol 2008;43:157-166.
27. Torres MP, Ballesteros E, Sánchez PD. Programas e intervenciones de apoyo a los cuidadores informales en España. Gerokomos 2008; 19:9-15.
28. Deeken JF, Taylor KL, Mangan P, Yabroff KR, Ingham JM. Care for the caregivers: a review of self report instruments developed to meansure the burden, needs and quality of life of informal caregivers. J Pain Symptom Manage 2003; 26:922-953.
29. Losada A, Izal M, Montorio I, Márquez M, Pérez G. Eficacia diferencial de dos intervenciones psicoeducativas para cuidadores de familiares con demencia. Revista de Neurología 2004; 38 (8): 701-8.
30. Escós C, Payán A, Yubero N, Santos A, Olivares A. Educación para la salud dirigido a cuidadores informales de enfermos encamados y semiencamados en el Área de Salud de Cuenca. Trabajo social y salud 2001;40: 487-99.
31. Conde J. Grups de suport a familias amb una persona gran discapacitada. Quaderns de Serveis Socials 1996; (11): 61-8.
32. Castellanos T, Nony D. Proyecto de educación para la salud a grupos de familiares, cuidadores de enfermos crónicos. Trabajo social y salud 2000; 37: 123-43.
33. Orem D. Modelo de Orem, Conceptos de enfermería en la práctica.by Mosby-Year Book, Inc. cuarta edición. 1991.